ARAÇ 3 / 5

Sınıf II – Sınıf III Görsel Ayırıcı

Dental mi, iskeletsel mi, fonksiyonel mi? Molar ve kaninden sefalometriye, yan yana karşılaştırmalarla iki dakikada ayırın.

BÖLÜM 1

Sınıf II: Dental mi, İskeletsel mi?

Aynı Sınıf II molar ilişkisi farklı nedenlerden gelir. Tedavi seçimi nedene göre değişir.

> *Molar ilişkisi tanıyı başlatır; ANB, Wits ve profil tanıyı koyar. Kesici kompansasyonu ise overjet'in gerçek farkı gizleyip gizlemediğini gösterir.*

AĞIZ İÇİ

DENTAL SINIF II

- Molar ve kanin Sınıf II; çoğunlukla üst dişlerin mesyal göçü (erken süt molar kaybı, yer kaybı)
- Overjet artışı üst kesici proklinasyonu veya diastemadan gelir
- Tek taraflı Sınıf II sık; orta hat sapmasıyla birlikte

İSKELETSEL SINIF II

- Molar ve kanin Sınıf II, iki tarafta benzer
- Overjet büyük; bölüm 2'de ise üst santraller retrokline, overjet küçük, derin kapanış belirgin
- Alt kesiciler proklinasyonda (kompansasyon)

SEFALOMETRİ

DENTAL SINIF II

- ANB normal sınırda (~2° ± 2)
- Wits normale yakın
- SNA ~82°, SNB ~80° civarında
- U1-SN artmış olabilir; IMPA normale yakın

İSKELETSEL SINIF II

- ANB 4°'nin üstünde
- Wits pozitif yönde artmış
- SNB düşük (mandibular retrognati, en sık) ve/veya SNA yüksek (maksiller prognati)
- IMPA artmış: alt kesiciler farkı kapatmaya çalışıyor

YÜZ

DENTAL SINIF II

- Profil düz veya hafif konveks
- Çene ucu normal konumda; dudaklar rahat kapanır ya da sadece üst dudak öne itilmiş

İSKELETSEL SINIF II

- Konveks profil, geride çene ucu, kısa boyun–çene hattı
- Dudak kapanışında mentalis kası gerginliği; alt dudak üst kesicilerin arkasına girebilir

Yapıcı kapanış testi

Hastadan mandibulayı Sınıf I kanin ilişkisine kadar öne getirmesini isteyin ve profilden bakın. Profil belirgin düzeliyorsa sorun büyük ölçüde mandibuladadır; büyüyen hastada fonksiyonel aparey (Twin Block, Herbst) adayıdır. Profil kötüleşiyorsa (çene öne fırlıyor) sorun maksilla veya dental kaynaklıdır.

BÖLÜM 2

Sınıf III: Dental, İskeletsel veya Psödo?

Sınıf III'te üçüncü bir seçenek vardır: fonksiyonel kayma ile oluşan psödo Sınıf III. Önce onu dışlayın.

AĞIZ İÇİ

DENTAL SINIF III

- Molar Sınıf III veya Sınıf I; ön çapraz kapanış bir veya birkaç dişte
- Üst kesiciler retrokline, alt kesiciler proklinasyonda (nedenin kendisi)
- Arkalar arasında kemik uyumsuzluğu yok

İSKELETSEL SINIF III

- Molar ve kanin Sınıf III, iki tarafta benzer
- Negatif overjet veya başa baş; sıklıkla posterior çapraz kapanış
- Üst kesiciler proklinasyonda, alt kesiciler retrokline (kompansasyon)

SEFALOMETRİ

DENTAL SINIF III

- ANB normal sınırda
- Wits normale yakın
- SNA ve SNB normale yakın
- Kesici eğimleri sorunun kaynağı

İSKELETSEL SINIF III

- ANB 0° veya negatif
- Wits negatif yönde artmış
- SNA düşük (maksiller retrüzyon) ve/veya SNB yüksek (mandibular prognati)
- IMPA azalmış: alt kesiciler geriye eğilmiş

YÜZ

DENTAL SINIF III

- Profil düz; orta yüz dolgun
- Çene ucu dengeli

İSKELETSEL SINIF III

- Konkav profil; orta yüz düz veya çökük, belirgin çene ucu
- Alt dudak üst dudağın önünde; aile öyküsü sık

Psödo Sınıf III'ü ayırma: sentrik ilişki testi

PSÖDO SINIF III (FONKSİYONEL)

- Sentrik ilişkide kesiciler başa baş gelebiliyor
- Kapanırken erken ön kontakt, ardından mandibula öne kayıyor
- Sentrik ilişkide molar ilişkisi Sınıf I'e yakın
- Sentrik ilişkide profil düzeliyor
- Üst kesiciler retrokline, alt kesiciler normal veya hafif proklinasyonda

GERÇEK İSKELETSEL SINIF III

- Sentrik ilişkide de negatif overjet devam ediyor
- Kayma yok veya çok az; sentrik ilişki ile alışılmış kapanış aynı
- Molar Sınıf III iki konumda da
- Konkav profil iki konumda da
- Dişsel kompansasyon belirgin

1. **Hastayı rahatlatın** — dik oturtun, başı dik; çene kaslarını gevşetmesini isteyin.
2. **Mandibulayı yönlendirin** — çene ucundan hafifçe geriye ve yukarı rehber olun; zorlamayın.
3. **İlk teması gözleyin** — temas kesicilerde mi? Başa baş geliyor mu?
4. **Kaymayı ölçün** — ilk temastan tam kapanışa mandibula ne kadar öne kayıyor, not edin.
5. **Profili iki konumda karşılaştırın** — sentrik ilişkide ve alışılmış kapanışta yan profil.

Sık hata

Sefalometriyi alışılmış kapanışta alıp iskeletsel Sınıf III demek. Fonksiyonel kayma varsa mandibula ileride görünür, ANB olduğundan kötü çıkar. Kaymayı klinikte kaydedin, yorumunuzu ona göre yapın.

Büyüyen hastada

Maksiller retrüzyonlu erken Sınıf III'te yüz maskesi, gerekirse RME ile birlikte, zamanında başlandığında anlamlıdır. Mandibular prognatide büyüme sonuna kadar izlem ve cerrahi seçeneğin konuşulması gerekir.

BÖLÜM 3

Özet Tablo: Yazdırın ve Asın

Hastanın değerini son sütuna yazın. Çoğunluk hangi sütunda ise oradan başlayın.

ÖLÇÜT	DENTAL II	İSKELETSEL II	DENTAL III	İSKELETSEL III	PSÖDO III	HASTA
Molar / kanin	Sınıf II, sıklıkla tek taraflı	Sınıf II, iki taraf	Sınıf I–III	Sınıf III, iki taraf	Sentrikte Sınıf I'e yakın	
Overjet	Artmış, kesici kaynaklı	Artmış (böl. 2'de küçük)	Ön çapraz, birkaç diş	Negatif / başa baş	Sentrikte başa baş	
ANB	~2° ± 2	> 4°	~2° ± 2	≤ 0°	Sentrikte ~normal	
Wits	Normale yakın	Pozitif artmış	Normale yakın	Negatif artmış	Sentrikte ~normal	
SNA / SNB	~82° / ~80°	SNB düşük ve/veya SNA yüksek	Normale yakın	SNA düşük ve/veya SNB yüksek	Normale yakın	
Profil	Düz–hafif konveks	Konveks, geride çene	Düz	Konkav	Sentrikte düzeliyor	
Üst kesici	Proklinasyon	Böl. 1: protrüzif · böl. 2: retrokline	Retrokline	Proklinasyon (kompansasyon)	Retrokline	
Alt kesici (IMPA)	~90°	Artmış (kompansasyon)	Proklinasyon	Azalmış (kompansasyon)	Normal / hafif artmış	
Kapanış testi	Öne alma profili bozar	Öne alma profili düzeltir	Kayma yok	Kayma yok	Sentrikte başa baş	
İlk düşünce	Dental mekanik, yer yönetimi	Büyüyorsa fonksiyonel aparey; değilse kamuflaj veya cerrahi	Kesici eğimi düzeltme	Büyüyorsa yüz maskesi; değilse kamuflaj veya cerrahi	Erken ön çapraz kapanış düzeltme	

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Tanıyı koyduysanız **Modül 05 Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III** bölümünü açın. Büyüyen bir hasta ise **Rehber 5 · Dentofasiyal Ortopedi Klinik Atlası** içindeki benzer vakaya bakın, sonra planı **Araç 4 · 4 Aşamalı Klinik Planlayıcı** üzerinde yazın.